

Ящур

Текущая версия страницы пока [не проверялась](#) опытными участниками и может значительно отличаться от [версии, проверенной 3 апреля 2026 года](#); проверки требуют [7 правок](#).

Ящур — [острое вирусное заболевание](#)^[1] [парнокопытных животных](#) из группы [зоонозов](#), характеризующееся [интоксикацией](#), [лихорадкой](#) и [афтозным](#) поражением [вымени](#), [слизистых оболочек ротовой](#) и [носовой полости](#)^[2], а также кожи [межпальцевых складок](#) и [околоногтевого ложа](#).

Этиология, эпизоотология и эпидемиология

Возбудителем ящура является [РНК](#)-содержащий [вирус](#) из семейства [пикорнавирусов](#), его размеры составляют от 27 до 30 нм. Характеризуется высокой степенью контагиозности (заразности) и дерматотропностью (свойством поражать кожные покровы). По антигенной структуре подразделяется на 7 [серотипов](#), в каждом из которых различают несколько [антигенных](#) вариантов. На территории СНГ обычно встречаются вирусы типов О и А. Возбудитель ящура устойчив к высушиванию и замораживанию, но быстро погибает при нагревании до 60 °C, действии [ультрафиолетовых лучей](#) и обычных [дезинфицирующих веществ](#). Вирусы культивируют на [тканевых культурах](#).

Вирус чрезвычайно вирулентен, размножается в куриных эмбрионах, а также в культурах переживающих и растущих тканей (эпителий языка, почек)^[3].

Ящур довольно широко распространён среди [животных](#). Наиболее подвержены инфекции молодые [парнокопытные](#)^[1] сельскохозяйственные животные ([крупный рогатый скот](#), [свиньи](#), [козы](#), [овцы](#), [олени](#) и др.)^{[2][4]}. От него могут страдать также [лошади](#), [верблюды](#),

Ящур



Поражение пасти

МКБ-11	1F05.3
МКБ-10	B08.8 (https://icd.who.int/browse10/2019/en#/B08.8)
МКБ-9	078.4 (http://www.icd9data.com/getICD9Code.ashx?icd9=078.4)
DiseasesDB	31707 (http://www.diseasesdatabase.com/ddb31707.htm)
MeSH	D005536 (https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D005536)



Медиафайлы на Викискладе

собаки, кошки и грызуны. У животных, перенёсших заболевание, и некоторых птиц установлено **вирусоносительство**, проявляющееся выделением возбудителя с испражнениями. Вирус распространён в странах **Африки, Азии, Среднего Востока и Южной Америки**^[2]. В ряде стран заболевание носит характер **эпизоотии** (эпидемий среди животных), повторяющихся через определённые промежутки времени. **Эпизоотия ящура в 2001 году** имела место в странах **Северной Европы** (в основном в **Великобритании и Нидерландах**).

Инфекционный процесс у парнокопытных характеризуется тяжёлым течением с **вирусемией, афтозными высыпаниями** и изъязвлениями в области **слизистых оболочек** полости рта, языка, носоглотки, носа, губ, на коже в межкопытных щелях, на вымени, иногда около рогов. Общая продолжительность болезни у животных — от 10 до 15 дней, продолжительность **инкубационного периода** — 2—4 дня. При злокачественном течении ящура, особенно у коров, более чем у 50 % заболевших животных наступает смертельный исход в течение 2—3 суток.

Ящуром могут заболеть люди^[1]. Основной путь инфицирования людей — через сырое **молоко** больных животных и продукты его переработки, реже через мясо. У лиц, непосредственно контактирующих с больными животными, возможна прямая передача инфекции (при доении, уходе, лечении, убое), воздушно-капельный путь заражения (при дыхании, кашле животных), а также через предметы, загрязнённые их выделениями. Описаны случаи внутрилабораторного инфицирования. От человека к человеку инфекция не передаётся. Дети более восприимчивы к ящуру, чем взрослые. Иммунитет типоспецифичен и зависит от наличия вируснейтрализующих антител.

Патогенез

Вирус проникает в организм через слизистые оболочки полости рта (реже — **пищеварительного и дыхательного** тракта) и повреждённую **кожу**. В месте внедрения возбудителя возникает первичный аффект (очаг поражения) — небольшая **везикула** (пузырёк), где вирус размножается и накапливается. Следующим этапом является вирусемия (проникновение вируса в кровь), приводящая к интоксикации. Выраженная дерматотропность вируса обуславливает его фиксацию в **эпителии** слизистых оболочек (полость рта, носа и уретры) и кожи (кисти и стопы), где отмечаются вторичные везикулы. С их появлением вирус в крови не обнаруживается.

Клиническая картина

Длительность инкубационного периода варьирует от 2 до 12 дней, обычно составляя 3—4 дня. Начало заболевания острое, с высокой температурой до 39—40 °C, с **ознобом**, головными и мышечными болями. К концу первых суток возникают симптомы поражения слизистых оболочек: жжение в полости рта, обильное **слюнотечение**, покраснение

конъюнктив, могут встречаться рези при мочеиспускании и лёгкая **диарея**. Объективно наблюдаются **отёчность** и покраснение слизистых оболочек щёк, **мягкого нёба, языка**, дужек и **губ**, на фоне которых несколько позже просматриваются мелкие пузырьки, первично заполненные прозрачным, а затем мутным содержимым. Через 1—2 суток пузырьки вскрываются, а на их месте остаются **эрозии**, обладающие тенденцией к слиянию и образованию обширных очагов изъязвления. При прощупывании регионарных лимфоузлов отмечаются их увеличение и болезненность. Больные не в состоянии разговаривать и глотать, что переносится ими тяжело, возникает обильное слюнотечение (до 2—4 л в сутки). Поражения слизистых оболочек носа, **уретры, влагалища** и конъюнктив характеризуются соответствующей симптоматикой. Характерным признаком на этом фоне являются везикулёзные высыпания в межпальцевых складках рук и ног и около ногтевых лож.

При неосложнённом течении заживление эрозий наступает к 5-му дню заболевания, общая продолжительность болезни составляет 5—7 дней. В ряде случаев могут встречаться затяжные формы инфекции (до нескольких месяцев) с повторными волнами высыпаний. Заболевание обычно протекает с малозначительной **смертностью**, но среди молодняка имеет высокую летальность из-за поражения сердечной мышцы^[2]. У детей ящур характеризуется обычно тяжёлым течением с явлениями **гастроэнтерита**. Прогноз обычно благоприятный, но при тяжёлом течении у детей — серьёзный.

Диагностика и дифференциальная диагностика



Больная свинья

При типичном течении диагноз не представляет трудностей. При менее чёткой симптоматике следует ориентироваться на данные эпидемического **анамнеза** (изучение

возможных путей заражения) и сведения об [эпизоотии](#) ящура.

Лабораторные данные: показатели общего анализа крови малоспецифичны — пониженный уровень [лейкоцитов](#) и [эозинофилия](#). Вирус выделяют из крови, [слюны](#), афтозных элементов и фекалий. Идентификация вируса осуществляется при помощи РСК и РНГА в парных [сыворотках](#) с интервалом в 6—8 дней.

В целях диагностики используют биологическую пробу с втиранием содержимого афт в подушечки лапок [морских свинок](#). При наличии вируса ящура у животных возникают типичные для инфекции высыпания.

Ящур дифференцируют от афтозного, токсического и кандидозного [стоматитов](#), [герпетической инфекции](#), [ветряной оспы](#), [энтеровирусных](#) заболеваний, [пемфигуса](#).

Иммунитет

Переболевание животного ящуром создаёт у него иммунитет к этому типу или варианту вируса, который вызвал заболевание. Впрочем, частично животное становится иммунным и к другим типам. У крупного рогатого скота он длится 8—12 месяцев, у свиней — 10—12 месяцев, у овец — около 18 месяцев^[3].

Патологоанатомические изменения

Афтозные поражения слизистых оболочек ротовой полости, кожи межкопытцевой щели, венчика, молочной железы, носового зеркала. Кроме того, афты и эрозии обнаруживают в слизистых оболочках рубца, реже — носовой полости, ануса, влагалища, препуция и на коже туловища. В сердце при внешнем осмотре и особенно на разрезе видны множественные сероватые или желтоватые очажки различной величины и формы^[5].

Лечение и профилактика

Люди, больные ящуром, подлежат госпитализации на срок не менее 14 дней. Назначается [диета](#), в механическом и химическом отношении максимально щадящая поражённые слизистые (полужидкая легкоусваиваемая пища 5—6 раз в день небольшими порциями, перед приёмом которой больному дают 0,1 г анестезина), обильное питьё. Иногда прибегают к кормлению через [зонд](#). Первостепенное значение имеет уход за полостью рта.

С первых дней начинают противовирусную терапию. Для этого применяют 0,25—0,5%-ную оксолиновую, 0,25—0,5%-ную флореналевую, 0,25—0,5%-ную теброфеновую, 4%-ную гелиомициновую, 0,25%-ную риодоксолевую, 50%-ную [интерфероновую](#) и другие мази. Используют растворы лейкоцитарного интерферона и 0,1—1%-ный раствор [РНК-азы](#).

Нанесение препаратов на поражённые участки слизистых и кожи осуществляют 3–5 раз в день.

Для ускорения процессов заживления можно применять [ультрафиолетовое облучение](#) и свет гелиево-неонового [лазера](#), а также аэрозольные препараты «Ливиан», «Левовинизоль», [пантенол](#), «Винизоль» и тому подобные. В тяжёлых случаях необходимы дезинтоксикационная терапия, сердечно-сосудистые, болеутоляющие, [антигистаминные препараты](#) и [витамины](#).

Профилактика ящура заключается в соблюдении мер личной предосторожности в очаге и санитарно-ветеринарных мероприятиях. В эндемичных районах обязательны пастеризация и кипячение молока, приготовление масла из обработанных сливок, а также тщательное соблюдение мер безопасности при уходе за больными животными. Важная роль принадлежит регулярной санитарно-просветительной работе среди населения. При появлении первых случаев заболевания животных ящуром в ранее благополучном регионе (местности) с целью недопущения дальнейшего распространения болезни рекомендуется немедленно убить всю неблагополучную группу животных на месте их нахождения с соблюдением ветеринарно-санитарных правил. Вывоз такого мяса и других продуктов убой в сыром виде за пределы хозяйства запрещают. Одновременно с убоем животных в хозяйстве проводят и другие мероприятия, предусмотренные инструкцией. Трупы животных, павших в очаге ящура, сжигают, молоко и навоз обеззараживают^[6].

Примечания

1. Ящур // Советский энциклопедический словарь / редколл., гл. ред. А. М. Прохоров. — 4-е изд. — М.: Издательство «Советская энциклопедия», 1986. — С. 1589.
2. М. К. Мустафин, Г. А. Осетова. [Карантинные болезни животных и птиц \(https://ksu.edu.kz/files/TB/book/vet/2019_ump_karantinnye_bolezni_zhivotnyh_i_ptic_mustafin_m_k_esetova_g_a.pdf\)](https://ksu.edu.kz/files/TB/book/vet/2019_ump_karantinnye_bolezni_zhivotnyh_i_ptic_mustafin_m_k_esetova_g_a.pdf) . — Костанай, 2019. — С. 8–11. — 78 с. — ISBN 978-601-7985-44-8.
3. Сосов Р. Ф. и др. Эпизоотология. — М.: Колос, 1969. — 400 с.
4. «[Ящур](#)» — статья в [Малой советской энциклопедии](#); 2-е издание; 1937–1947 гг.
5. Жаров А. В., Шишков В. П. и др. Патологическая анатомия сельскохозяйственных животных. — М.: Колос, 1995. — 543 с.
6. [Ящур \(https://web.archive.org/web/20200801100200/http://89.rospotrebnadzor.ru:80/directions/epid_nadzor/146902\)](https://web.archive.org/web/20200801100200/http://89.rospotrebnadzor.ru:80/directions/epid_nadzor/146902) . Меры профилактики. Сайт Управления [Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу](#). 89.rospotrebnadzor.ru. Дата обращения: 29 ноября 2020. Архивировано из [оригинала \(http://89.rospotrebnadzor.ru/directions/epid_nadzor/146902\)](#) 1 августа 2020 года.

Литература

- *Овсякова Н.* Ящур диких копытных // «Охота и охотничье хозяйство»: журнал. — 1973. — № 3. — С. 19.
- [Ящур \(https://web.archive.org/web/old.bigenc.ru/text/4921153\)](https://web.archive.org/web/old.bigenc.ru/text/4921153) // Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов. — М. : Большая российская энциклопедия, 2004—2017.

Ссылки

- [Полферов Я. Я. Ящур](#) // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

В статье есть список источников, но не хватает сносок.

[Сообщить об ошибке](#)